内科含诊断 呼吸衰竭（含酸碱失衡判断小结）★☆☆（0~1题）

（2007、2008、2010、2017、2024）

	诊断	机制	栗子	吸氧浓度
Ⅰ型	PaO_2 ＜ 60 $PaCO_2$ 正常或降低	肺换气 障碍为主	急性：ARDS、急性肺栓塞、急性肺水肿（急性左心衰）、严重肺部感染 慢性或急性：间质性肺疾病	高浓度吸氧
Ⅱ型	$PaCO_2$ ＞ 50 伴或不伴低氧血症	肺通气 障碍为主	急性：严重哮喘、脑干出血、膈肌麻痹（重症肌无力）、镇静催眠剂中毒、气管异物 慢性或急性：COPD、脊柱侧凸（胸廓畸形）	低浓度吸氧 （＜ 35%）

慢性Ⅱ型呼衰出现 pH ↑“你搞的”（2009）

①机械通气过度“CO_2 走的太快就像龙卷风”
②补碱不当
③利尿过量
④氯化钾的补充不及时

呼吸兴奋剂（2008）

①适合以中枢抑制为主的通气障碍（如脑干出血、镇静催眠剂中毒）
②不适合以换气障碍为主
③必须保持气道通畅
④神经传导障碍、呼吸肌完全病变者禁用
⑤脑缺氧、脑水肿未纠正而出现频繁抽搐者慎用

酸碱失衡判断小结（2007、2013）

	正常值	意义
pH	7.35~7.45	↑→碱中毒失代偿 ↓→酸中毒失代偿
$PaCO_2$	35~45	↑→呼酸 ↓→呼碱
BE	-2.3~ +2.3	↑→代碱 ↓→代酸
HCO_3	22~27	↑→代碱 ↓→代酸
K	3.5~5.5	一般“高钾酸中毒、低钾碱中毒”